

VOS DROITS EN EHPAD

Ce que la loi vous garantit. Ce que vous pouvez exiger.

Guide D — Série pratique EHPAD · Culture du soin

Sommaire

1. Les droits fondamentaux du résident

Ce que la loi garantit à votre proche — et donc à vous.

2. Votre accès au dossier médical

Qui peut accéder à quoi, comment le demander.

3. La personne de confiance — un rôle à formaliser

Ce que ce statut change — et pourquoi le désigner le plus tôt possible.

4. Les droits liés aux soins

Consentement, refus de traitement, directives anticipées.

5. Le contrat de séjour — ce qu'il doit contenir

Vos engagements, ceux de l'établissement, et comment quitter l'établissement.

6. Comment faire une réclamation officielle

Étapes, formules, interlocuteurs — pour être pris au sérieux.

Introduction

Beaucoup de familles font valoir leurs droits trop tard — souvent parce qu’elles ne savaient pas qu’elles en avaient. Ou parce qu’elles croyaient qu’exiger quelque chose allait “braquer” l’équipe.

Connaître ses droits n’est pas une posture agressive. C’est une posture claire. Et la clarté — quand elle est exercée avec respect — inspire plus de sérieux qu’elle n’en crée des tensions.

Ce guide n’est pas un guide juridique. Ce n’est pas non plus un guide pour aller au conflit. C’est un guide pour que vous sachiez exactement ce à quoi vous avez droit — et comment l’exercer sans perdre le lien avec l’établissement.

Ce que j’observe sur le terrain

Les établissements sérieux n’ont pas peur des familles informées. Au contraire — une famille qui connaît ses droits et les exerce calmement est souvent plus facile à travailler avec qu’une famille perdue qui explose au mauvais moment. Connaître ses droits, c’est aussi savoir ce qu’on peut raisonnablement attendre — et ce qu’on ne peut pas.

1. Les droits fondamentaux du résident

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale pose un socle de droits pour toute personne accueillie en établissement. Voici les principaux — ceux que vous pouvez invoquer.

Le droit au respect de la dignité

Votre proche a droit à être traité avec respect, quelle que soit son état de dépendance. Cela inclut le respect de son corps, de son intimité, de ses habitudes, de son histoire. Si vous observez des comportements irrespectueux envers votre proche — un ton brusque, une manipulation non consentie, un manque d'égards — vous pouvez et devez le signaler.

Le droit à l'information

Votre proche a le droit d'être informé de son état de santé, des soins qui lui sont prodigués et des décisions qui le concernent — dans des termes qu'il peut comprendre. Si votre proche n'est plus en mesure de recevoir et de traiter ces informations, elles peuvent vous être transmises en tant que famille ou personne de confiance.

Le droit au libre choix

Dans la mesure du possible, votre proche conserve le droit de choisir : son médecin traitant, ses activités, ses sorties, ses visites. L'institution ne peut pas lui imposer un rythme ou des contraintes sans justification. Si votre proche exprime un souhait — même mineur — ce souhait doit être pris en compte.

Le droit à la vie privée

Sa chambre est son espace privé. Personne ne peut y entrer sans frapper et attendre une réponse — sauf en cas d'urgence. Il a le droit de recevoir qui il veut, quand il le souhaite, dans les limites du règlement intérieur. Il a aussi le droit à la confidentialité de sa correspondance et de ses communications.

Le droit à la sécurité

L'établissement est responsable de la sécurité physique de votre proche. Chutes, accidents, fugues, maltraitance — il a l'obligation de mettre en place des mesures de prévention adaptées. Si vous estimez que ces mesures sont insuffisantes, vous pouvez le signaler formellement.

Ces droits ne sont pas des privilèges. Ce sont des garanties légales. Ils s'appliquent à chaque résident, dans chaque établissement, quel que soit son niveau de dépendance.

2. Votre accès au dossier médical

Le dossier médical contient toutes les informations de santé de votre proche : diagnostics, traitements, résultats d'analyses, comptes-rendus de consultations, évaluations. Savoir qui peut y accéder — et comment — est essentiel.

Qui peut accéder au dossier

- **Le résident lui-même**, s'il est en capacité de le demander. C'est son droit absolu.
- **La personne de confiance désignée**, si le résident n'est plus en mesure de prendre ses décisions seul.
- **Le tuteur ou curateur**, s'il y a une mesure de protection juridique.
- **Les ayants droit après le décès**, dans certaines conditions (pour connaître les causes du décès, défendre la mémoire du défunt, faire valoir leurs droits).

Attention : la famille au sens large (enfants, conjoints) n'a pas automatiquement accès au dossier médical. C'est pourquoi le statut de personne de confiance est crucial — voir chapitre 3.

Comment faire la demande

- La demande se fait par écrit — courrier ou mail — adressée à la direction de l'établissement.
- L'établissement a huit jours ouvrés pour répondre (ou deux mois si le dossier date de plus de cinq ans).
- Vous pouvez consulter le dossier sur place ou en demander une copie. La copie peut être facturée (frais de reproduction).
- Si l'établissement refuse ou ne répond pas — vous pouvez saisir la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA).

Modèle de demande d'accès au dossier

Madame, Monsieur,

Je suis [lien de parenté] de M./Mme [nom du résident], résident(e) dans votre établissement depuis le [date] en chambre [numéro]. Je suis désigné(e) comme [personne de confiance / tuteur / représentant légal].

Conformément à l'article L1111-7 du Code de la santé publique, je sollicite l'accès au dossier médical de mon/ma [lien]. Je souhaite [consulter le dossier sur place / en recevoir une copie].

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Dans l'attente de votre réponse, je vous adresse mes cordiales salutations.

Accéder au dossier médical n'est pas un acte de défiance. C'est un droit que la loi vous accorde pour vous permettre d'être un accompagnant éclairé.

3. La personne de confiance — un rôle à formaliser

La personne de confiance est une notion juridique précise, créée par la loi Kouchner de 2002 et renforcée par la loi Claeys-Leonetti de 2016. Ce n'est pas automatiquement le conjoint ou l'enfant aîné. C'est la personne que le résident a choisi et désigné officiellement.

Ce que ce statut permet

- Être consulté et informé quand le résident ne peut plus s'exprimer.
- Assister aux consultations médicales si le résident le souhaite.
- Être le premier interlocuteur de l'équipe médicale en cas de décision difficile.
- Accéder au dossier médical si le résident n'est plus en mesure de le faire lui-même.

Comment formaliser la désignation

La désignation se fait par un document écrit, daté et signé par le résident. L'EHPAD doit vous proposer un formulaire à l'entrée. Si ce n'est pas le cas — demandez-le. La personne de confiance peut être révoquée ou changée à tout moment, par écrit.

Personne de confiance vs tuteur — la différence

Le tuteur est nommé par un juge et possède des pouvoirs légaux de décision au nom du résident (actes administratifs, financiers, parfois médicaux). La personne de confiance est un rôle d'accompagnement et de représentation dans le domaine médical uniquement. Les deux peuvent coexister — mais leurs rôles ne se confondent pas.

Désigner une personne de confiance le plus tôt possible — c'est donner à votre proche le pouvoir de choisir qui parlera en son nom quand il ne pourra plus le faire.

4. Les droits liés aux soins

Le consentement aux soins

Tout acte médical nécessite le consentement du patient. Même en EHPAD, même pour les personnes dépendantes. Quand votre proche n'est plus en mesure de consentir clairement, l'équipe doit rechercher sa volonté de toutes les façons possibles : comportements, réactions, directives anticipées, avis de la personne de confiance.

Le droit de refuser un soin

Votre proche a le droit de refuser un soin, même si ce refus met sa santé en danger. L'équipe doit informer, expliquer les conséquences, proposer des alternatives — mais elle ne peut pas imposer. Si votre proche refuse une toilette, un traitement, une activité — son refus doit être respecté et documenté.

Les directives anticipées

Ce sont des instructions écrites par lesquelles votre proche exprime ses volontés sur sa prise en charge médicale future — notamment en fin de vie. Elles s'imposent aux médecins (sauf cas exceptionnels prévus par la loi). Si votre proche en a rédigé — assurez-vous qu'elles sont bien connues de l'équipe et présentes dans son dossier.

Si votre proche n'en a pas — et qu'il est encore en mesure de le faire — encouragez-le. Un notaire, un médecin ou l'établissement peut l'aider à les rédiger.

La contention — ce que l'établissement peut et ne peut pas faire

La contention physique (sangles, barrières de lit, fauteuil avec tablette bloquée) est strictement encadrée. Elle ne peut être utilisée que comme mesure exceptionnelle, documentée, révisée régulièrement, et justifiée par un risque pour la sécurité. Si vous observez une contention qui vous semble abusive ou non justifiée — posez la question à la cadre et au médecin. Vous avez le droit de demander des explications écrites.

Votre proche garde ses droits de patient. La dépendance ne les efface pas. Elle les rend plus importants à défendre.

5. Le contrat de séjour

Le contrat de séjour est le document qui formalise les engagements entre votre proche (ou vous) et l'établissement. Il doit être signé dans les quinze jours suivant l'entrée.

Ce qu'il doit obligatoirement contenir

- La description des prestations proposées et leurs tarifs.
- Les modalités de révision des tarifs.
- Les conditions de résiliation — délai de préavis, remboursement en cas de décès ou de départ anticipé.
- Les droits et obligations du résident.
- Les conditions d'hospitalisation temporaire.

Quitter l'établissement — ce que vous devez savoir

Votre proche peut quitter l'établissement à tout moment. Le contrat prévoit un délai de préavis — généralement un mois. Pendant ce mois, la chambre reste réservée et facturée. En cas de décès, la facturation s'arrête à une date prévue au contrat — vérifiez laquelle.

L'établissement peut également résilier le contrat — mais uniquement dans des conditions très encadrées (comportement grave, non-paiement, évolution de l'état de santé incompatible avec les capacités de l'établissement). Il doit vous laisser un délai suffisant et vous aider dans la recherche d'une solution alternative.

Lisez le contrat avant de le signer. Posez des questions sur ce que vous ne comprenez pas. Gardez-en un exemplaire.

6. Comment faire une réclamation officielle

Quand les voies informelles n'ont pas fonctionné, il existe des voies formelles. Voici comment les utiliser — dans l'ordre.

Étape 1 — La réclamation écrite interne

Adressez un courrier ou mail à la direction, exposant les faits, les démarches déjà effectuées et votre demande. Précisez que vous attendez une réponse écrite sous un délai raisonnable (huit à quinze jours). L'établissement est tenu d'accuser réception et de vous répondre.

Étape 2 — Le Médiateur de l'établissement

Chaque établissement de santé dispose d'une Commission des Usagers (CDU) et d'un médiateur. Vous pouvez demander à être reçu par le médiateur médical ou non médical pour exposer votre situation. C'est une étape clé avant de sortir de l'établissement.

Étape 3 — L'Agence Régionale de Santé (ARS)

L'ARS est l'autorité de tutelle des EHPAD. Elle peut diligenter une inspection si elle est saisie d'une plainte grave. Vous pouvez la contacter par courrier ou via son site internet. Une plainte à l'ARS est un acte sérieux qui déclenche une procédure officielle — à réserver aux situations réellement graves.

Étape 4 — Le Conseil Départemental

Pour les questions relevant de la dépendance et du financement (APA, aide sociale à l'hébergement), le Conseil Départemental est l'autorité compétente. Il peut également intervenir en cas de difficulté grave dans un établissement.

Étape 5 — Le Défenseur des droits

En cas de violation des droits fondamentaux (discrimination, maltraitance, atteinte à la dignité), vous pouvez saisir le Défenseur des droits. La saisine est gratuite et

accessible en ligne. C'est une autorité indépendante qui peut intervenir auprès des établissements.

Une réclamation bien fondée, bien rédigée et adressée au bon interlocuteur — c'est ce qui fait bouger les choses.

Informé, vous n'êtes plus démunis.

Vous savez ce à quoi vous avez droit. Et comment l'obtenir.

—

Ce guide fait partie de la série pratique EHPAD. Les autres guides de la série :

- **Guide A — Qui est qui :** rôles, responsabilités, bons interlocuteurs.
- **Guide B — Parler à l'équipe :** quand, comment, à qui, par écrit.
- **Guide C — Les réunions :** CVS, synthèses, projet de vie.
- **Guide E — Le quotidien :** soins, repas, nuit, sorties, argent.
- **Guide F — Quand ça coince :** conflits, signalement, recours.
- **Guide G — Le changement d'EHPAD :** quand et comment partir ailleurs.

—

Et si vous avez besoin d'aide pour rédiger une réclamation, comprendre une situation juridique ou ne pas traverser seul un moment difficile — je suis là.

[Votre lien de contact / site]

— *Culture du soin*